

28. 수면장애

- **중요 포인트**
 - 1. 전정성/비전정성, 말초성/중추성 구별해 적절한 진단 및 치료 계획 수립
 - 2. 응급치료가 필요한 환자 감별

- **Overview**

- **평가 목표**

평가목표		
1) 수면 양상 평가해 정상/수면장애 구별 2) 수면장애 일으키는 원인 파악/진단 및 치료계획 수립		
중요성		
불면증은 수면장애의 대표적 질환 성인의 1 년 유병률이 35~45%나 되는 매우 흔한 질환 수면장애에 의해 개인적으로 삶의 질이 저하되고, 사회적으로도 손실 심각 원인도 매우 다양하므로 수면장애 유발하는 다양한 질환 감별하고, 그에 상응하는 치료 선택 중요		
원인	3 주 미만 □ 일과성 수면장애 수면환경변화, 스트레스, 교대근무, 약물, 급성질환	
	원발성/일차성 수면장애: 수면무호흡증/하지불안/주기성사지운동/RBD/기면증/야경증 Or 수면장애와 주간 증상이 최소 1 주일 3 회 이상, 3 개월 이상 지속 □ 일차성 불면장애	
	속발성/이차성 수면장애: MDD/물질사용 유도 수면장애/폐경 유도 수면장애/신체질환 유도 수면장애	
구체적인 성과		
병력 청취	수면 및 주간 수면 관련 행동 평가	
	수면환경 수면위생 평가	잠자기 전 저녁시간: 음식/운동/흡연 잠자리 주변 환경: 소음/난방/환기 잠 안오면 행동: 기다림/TV/폰/음주 자다깨면: 시계확인/물/담배
	다른 정신질환/물질사 용장애/신체질환 동반 여부 확인	일시적 원인: 스트레스/생활패턴변화/근무시간/직업/해외여행력 술/담/커피/녹차/야식 폐경/PMS 질환: 갑상샘항진증 천식 GERD 전립샘 신경계 심부전 약물: 항고혈압제, 기관지확장제, 스테로이드, 비충혈제/비염약은 불면증 유발 가능
		환자/의사관계

신체진찰	신체질환, 물질사용에 의한 수면장애를 감별	VS 확인 키/몸/BMI 눈(빈혈/탈수) 입/편도/목젖(폐쇄성수면무호흡증) 목(갑상선) 손(피부 긴장도) 다리(오목부종) 흉부진찰 + 심음청진 심음/호흡음 청진(시간되면 시속타청 다 시행)	
	정신상태 평가 > 신체진찰에 포함되어 있으나 사실 병력청취에 가까운듯?	[주요 우울장애] ① 하루종일 우울 ② 관심있던 일에 흥미 저하 ③ 입맛/잠/피로 ④ 불안,초조/ 집중력저하,건망증 ⑤ 죄책감/ 자살-생각,시도,계획	
	환자/의사관계	/	
진단 및 치료	환자/의사관계	치료 받으면 잘 호전될 수 있습니다. 증상 있을 때 잘 오셨습니다. QoL 나빠지 않으면 1 하루에 5-6 시간만 자도 괜찮다, 나이 들면 생리적으로 잠이 준다고 위로/위안	
	수면장애 확인하고 감별할 수 있는 검사계획	심리검사 1 잠이 잘 오지 않는 원인 중에는 스트레스나 우울감, 불안 같은 심리적인 요인이 큰 비중을 차지하기도 해서 설문지 형태의 심리검사를 통해 현재 마음 상태가 어떤지, 그리고 이것이 수면에 어떤 영향을 주고 있는지 객관적으로 파악 수면다원화검사 1 잠자는 동안 몸에서 일어나는 모든 생체 신호를 정밀하게 측정하는 '수면의 종합검진' 1 병원에서 하루 주무시면서 검사하는 과정에 대한 동의 수면일지 1 수면 습관의 규칙성 파악 혈액검사/갑상선 기능검사 1 신체적/내과적 원인 감별	
	원인 질환의 치료 계획 수립(비약물치료 1 수면진정제)	생활습관 교정(제일 중요), 아주 심할 때만 복용할 수 있게 수면제도 처방해드릴 수 있음	
환자 교육	환자 교육	수면제 복용 규칙: 잠들기 직전 복용, 술과 절대 함께 먹지 않기, 임의로 증량하지 않기, 충분한 수면시간 확보할 수 있는 상황일 때 먹기 장기간 수면제 사용은 부작용으로 문제 생길 수 있기 때문에 주의하셔야 합니다. - 내성, 의존성 : 계속 먹으면 스스로 잠드는 힘을 잃어버려 나중에는 약 없이는 아예 못 자는 상태 - 복용 시 특히 어르신들의 경우 자다 깨서 헛것을 보거나(섬망), 자는 동안 했던 행동 기억 못할 수도(생각보다 많이 발생함) - 갑자기 약 끊으면 더 심한 불면증 올 수 있으므로 의사의 지시에 따라 서서히 양 줄이기 - 고령 환자의 경우 수면제로 인한 근육 이완 효과 때문에 밤에 낙상 사고 주의	
	수면환경 및 수면위생에 대해 환자 교육	Bad 덥게/지나치게 습하게/밝게/시끄럽게 낮잠 20-30 분 이상 침대에서 식사/책/운동/전화/핸드폰/시계/TV 침대에서 걱정하기(특히나 수면에 대해) 수면 전 과식, 다량 수분 금지 수면 전 알코올/커피/녹차 금지 수면 직전 운동 금지	Good 수면환경 시원하게/어둡게/조용하게 규칙적 기상 시간 잠 잘 때만 침대에 누워있기 잠이 오지 않으면 침실 밖에서 다른 일 하기 걱정해 대해서 적어두고 잡생각 그만, 아침에 하기 배고프면 수면 전 간략한 간식 적절하고 규칙적인 운동 수면 1 시간 전 마음 가라앉히기/명상/스트레칭 수면 1 시간 전 미지근한 물 샤워
		+++ Q. 인터넷에서 파는 멜라토닌 젤리/약/음료수 먹어도 될까요? 멜라토닌은 우리 몸에서 나오는 수면 호르몬이라 도움이 될 수 있지만, 현재 환자분의 불면증 원인이 무엇인지 정확히 파악하는 것이 우선입니다. 시중에 파는 제품은 함량이 일정하지 않을 수 있으니, 우선 오늘 안내해 드린 수면위생을 1~2 주간 실천해 보시고 증상이 나아지지 않으면 그때 의학적인 처방을 통해 안전하게 복용하시는 것을 추천해 드립니다. >> 주로 인터넷에서 파는 멜라토닌 용량은 (직구하지 않는 이상) 매우 적은 용량! 하지만 와르르 먹어버리면멜라토닌 성분이 주중에 남아있게 되면서 편두통 등 다른 증상 발생 가능함. 의존도 높아질 수 있음. 근데 사실 전 먹어요.	

원인 질환 정리

계통	질환	질환 설명	병력청취	신체진찰	치료
	일과성 수면장애 1 (DSM 5에서는 단기불면장애 1 개월 이상 3 개월 미만)	심리적/환경적 요인에 의한 일시적 현상	3 주 미만 , 수면환경변화, 스트레스, 교대근무, 약물, 급성 질환		수면 위생 교육, 생활습관 교정
원발성 수면장애	불면장애 6+2		수면 개시의 어려움, 수면 유지의 어려움, 이른 아침에 각성하여 다시 잠들기 어려움 (주 3 회 이상, 3 개월 이상) = 다른 원인 없이 오랫동안 입면/수면유지 힘들		수면위생 개선, 자극조절(졸릴 때만 침대에 눕기), 수면제한(실제 수면시간 계산해서 그만큼만 누워있게 하기), 인지치료(수면에 대한 왜곡된 인지 교정), 비약물치료 시도 이후에 단기적으로 Zolpidem, BZD 수면제, Melatonin 등
	폐쇄성 수면 무호흡증 1+1	뇌호흡중추 기능 정상 상기도 폐쇄로 인해 무호흡 또는 저호흡 발생	비만, 코골이, 수면 중 호흡 멈추거나 알아짐, 피로, 주간졸림 편도 크고 목뚝 길어 기도 좁음		양압환기, 체중감량, 잠자는 자세 바꾸기(옆으로 자기), 호흡 억제 요인 제거(알코올, 수면제, 진정제 등) 수술(매우 심할 경우 고려, 기관지 절개술 등)
	렘수면 행동 장애 0+1	보통 꿈을 꾸는 단계(렘수면)에서 근육 이완되어 몸 움직이지 않아야 정상인데, 이 조절 기능 약해져 꿈 내용을 몸으로 직접 실행	수면 중 소리, 움직임 (주먹질, 발로 차기), 같이 자는 사람 부상		약물치료(Clonazepam, melatonin 등), 안전한 침실환경(위험한 요인 제거)
	악몽 장애 1		악몽 반복적 발생, 악몽에 대한 공포로 인해 불면 증상 발생		체계적 탈감작, 노출치료, 인지치료
	기면증/발작 수면	뇌 의 신경전달물질(하이포크레 틴) 부족으로 의지와 상관 없이 갑자기 강한 잠 쏟아지거나 몸 힘빠짐	억누를 수 없는 수면욕구 가 하루에 반복적으로, 탈력발작, 주간 졸리움, 잠에 들거나 깼 때 환각이나 마비		[검사] CXR, 혈액/객담 배양, CBC 주간졸림증: CNS 각성제(modafinil 등) 탈력발작: SSRI 등, 교육, 생활방식 변경
	일주기리듬 수면-각성 장애 (circadian rhythm sleep-wake disorder) 1	몸의 생체 시계와 실제 생활 시간이 서로 맞지 않아, 원하는 시간에 잠들지 못하거나 낮 동안 비정상적으로 졸음 쏟아짐	낮 시간 외의 근무하는 교대근무형		광치료(푸른 빛에 노출시켜 생체리듬 reset) 환경치료(잠들기 전 빛 노출 최소화, 아침에 퇴근할 때 선글라스 쓰기, 아침에 잘 때 침실 어둡게 하기)
	비렘수면 각성장애	잠을 자던 뇌가 잠에서 깼 때, 몸을 움직이는 부분만 먼저 깨어나고 기억과 의식 담당하는 부분은 여전히 잠들어 있음	어떤 일이 있었는지 기억하지 못함 몽유병/수면보행증: 걸어다님, 복잡한 대화나 정교한 활동 불가능 야경증/수면놀람증: 자다가 소리지름, 동공산대/빈맥/빈호흡/발한 등 자율신경 항진		특별한 치료는 없음 사고 발생하지 않도록 예방
	하지불안증 후군	도파민, 철분 부족에 인한 이상감각	빈혈 다리 이상감각, 불편감, 근질거림 ▯ 다리 움직이고 싶음, 다리 움직임/주무르면 불편감 일시적 감소		[검사] 페리틴 수치, 빈혈 검사 [치료] 철분보충, 약물치료(dopamine agonist)
속발성 수면장애	주요우울장애		우울, 의욕저하, 식욕저하, 죄책감 피로		[검사] Beck 우울척도 검사 [치료] SSRI
	물질/약물		물질/약물 오남용		약물 중단/감량, 대체 약물 투여

	사용으로 유도된 수면장애		Ex) 카페인, 알코올, 니코틴 스테로이드 - 중추신경계 자극 및 대사 활성화 항고혈압 - 베타차단제 : 멜라토닌 분비 억제 기관지확장제 - 테오필린 계열 : 심박수 증가 및 신경과민 유발 SSRI, SNRI - 뇌 내 세로토닌 수치 높여 각성 충혈제거제 - 슈도에페드린: 교감신경 흥분	
	폐경으로 유도된 수면장애		얼굴 화끈거림, 예민, 무기력	[검사] 혈중 FSH, estradiol 농도 검사 [치료] 호르몬 대체요법
	신체질환으 로 유도된 수면장애		현재 앓고 있는 질환/ 아픈 곳 묻기 근골격계 질환(퇴행성 관절염, RA, 오십견-특히 야간통이 특징) 신경계 통증(허리/목 디스크로 인한 방사통, 대상포진 후 신경통, 당뇨병성 말초신경병증 등) 호흡기 및 심장(COPD, 천식, 울혈 심부전) 내분비(갑상선기능항진, 당뇨병-다뇨) 소화기(역류식도염, 전립선비대증)	기저질환치료, 통증 조절

● **대본**

자기소개/환자확인/환자동의/활력징후	
적고 있지만 비밀 유지 될 것이니까 편하게 말씀해주셔도 된다고 말해주기	
“진료 대기 시간이 길었는데 오래 기다리시느라 고생 많으셨습니다./몸도 좋지 않은데 병원까지 오셔서 기다리시느라 고생이 많으셨습니다.”	
O	언제부터 갑자기/서서히
L	어디서 잠을 자는지 수면환경은 편하고 아늑한지
D	그때부터 계속 주: 일주일에 며칠 자는 게 힘든지 일: 하루에 몇시간 자는지 구체적 시간: 몇시에 침대에 누워서, 몇시에 자고, 몇시에 일어나는지
Co	악화/유지
Ex	이전에도? □ 치료
C	개방형: “ 자세히 설명해주시겠어요? ” 양상: 전/중/후 -> 잠들기 힘들(입면 장애), 중간에 깬(유지 장애)/악몽, 너무 일찍 깬 정도: 일상/낮 생활 지장 QoL □ “ 많이 힘들었습니다.” 수면위생: 환경 + 전/중/후 같이 주무시는 분 있어요? → 코 고세요? 잠들기 전 저녁시간 어떻게 보내나요? (자기 전 음식, 운동, 흡연) 주변 환경 편안? (소음, 난방, 환기) 잠이 안 오면 뭐하나요? (누워서 계속 기다림, TV, 컴퓨터, 음주) 중간에 자주 깨나요? 깨면 뭐하나요? (물 마시기, 담배 피우기, 시계 확인)
A	개방형: “ 다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇가지 자세하게 확인해보겠습니다.” [수면무호흡] 코골이/ 수면 중 숨을 잘 못 쉬는지/ 키 체중 [하지 불안] 잠들기 전 다리가 불편한 느낌/ 움직이면 호전 [렘 수면] 자다가 소리지름/ 같이 자는 사람 불편함 호소/ 악몽 (with 악몽장애) [기면병] 낮에 갑자기 잠들/ 웃거나 화내다가 팔다리 힘빠짐 [우울증] 우울/ 불안/ 식욕 □ [주요 우울장애] 하루종일 우울 관심있던 일에 흥미 저하 입맛/잠/피로 불안,초조/ 집중력저하,건망증 죄책감/ 자살-생각,시도,계획 암기법: 코다리 움직이기 정신 (코골이/다리불편/움직임/렘)/기면증/정신)
	내과적 질환: [갑상샘항진증] 더위불내성/ 체중감소/ 두근거림 [천식] 기침/ 호흡곤란/ 쌉쌉거림 [GERD] 속쓰림/ 신물 올라옴/ 흉통 [전립샘, 요실금] 밤에 소변 보기 위해 자주 깨나요?/ 소변 보기 힘든가요? [신경계, 추간판탈출증] 허리/목 통증/두통/떨림 암기법: 갑천 GP
F	개방형: “ 증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요? ” 낮잠 스트레스 생활패턴변화 근무시간표 변화/직업 해외여행/시차
E	-
요약 및 PPI	“지금까지 말씀하신 것을 요약하자면 ~.” “제가 질문을 많이 했는데 잘 대답해주셔서 감사합니다. 몇가지만 더 여쭙도록 하겠습니다.”
외	외상/수술
과	HTN/DM/고지혈증/결핵/간염

	정신질환
약	약물/영양제/한약/즙 약 증량/변경 (불면증 유발 약물 : 항고혈압제, 기관지확장제, 스테로이드, 비염약=비충혈제)
사	술/담배/커피카페인 녹차 (몇잔, 밤에도)/ 직업 (교대근무, 밤낮바뀜)/ 스트레스 운동 (언제, 얼마큼), 식사 (야식)
가	가족 중 수면장애 진단/ 비슷한 증상 + 정신과 질환
여	규칙적 or 폐경 (얼굴 화끈, 예민)
요약 및 PPI	"네. 이로써 문진은 마치도록 하겠습니다." "혹시 더 말씀해주시고 싶은 것 있으실까요? 편하게 말씀해주세요."

환자동의 "정확히 어디가 아픈지 확인하기 위해 신체진찰을 진행해야 합니다. 과정 중에 신체 노출과 접촉이 있을 수 있으나, 불편하시지 않게 필요한 부분만 노출하고 최대한 신속히 확인하겠습니다. 괜찮으실까요? 중간중간 불편하시면 언제든 말씀해주세요."	
기본 신체진찰	VS 확인, BMI/키/몸
	VS 확인 키/몸/BMI 눈(빈혈/탈수) 입/편도/목젖(폐쇄성수면무호흡증) 목(갑상선) 손(피부 긴장도) 다리(오목부종) 흉부진찰 + 심음청진 심음/호흡음 청진(시간되면 시속타청 다 시행)

안심: 치료 받으면 잘 호전될 수 있습니다. 증상 있을 때 잘 오셨습니다. QoL 나쁘지 않으면 1 하루에 5-6 시간만 자도 괜찮다, 나이 들면 생리적으로 잠이 준다고 위로/위안	
기본 진단검사	특이 진단검사
심리검사 1 잠이 잘 오지 않는 원인 중에는 스트레스나 우울감, 불안 같은 심리적인 요인이 큰 비중을 차지하기도 해서 설문지 형태의 심리검사를 통해 현재 마음 상태가 어떤지, 그리고 이것이 수면에 어떤 영향을 주고 있는지 객관적으로 파악 수면다원화검사 1 잠자는 동안 몸에서 일어나는 모든 생체 신호를 정밀하게 측정하는 '수면의 종합검진' 1 병원에서 하루 주무시면서 검사하는 과정에 대한 동의 수면일지 1 수면 습관의 규칙성 파악 혈액검사/갑상선기능검사 1 신체적/내과적 원인 감별	폐경: 성호르몬 농도 검사 신체질환 유도: 각 원인에 따른 혈액검사/영상검사 MDD: Beck 우울척도 검사 하지불안증후군: 철분/빈혈 검사 기면증:
기본 치료	특이 치료
생활습관 교정(제일 중요), 아주 심할 때만 복용할 수 있게 수면제도 처방해드릴 수 있음 수면제 복용 규칙: 잠들기 직전 복용, 술과 절대 함께 먹지 않기, 임의로 증량하지 않기, 충분한 수면시간 확보할 수 있는 상황일 때 먹기 장기간 수면제 사용은 부작용으로 문제 생길 수 있기 때문에 주의하셔야 합니다. - 내성, 의존성 : 계속 먹으면 스스로 잠드는 힘을 잃어버려 나중에는 약 없이는 아예 못 자는 상태 - 복용 시 특히 어르신인 경우 자다 깨서 헛것을 보거나(섬망), 자는 동안 했던 행동 기억 못할 수도(생각보다 많이 발생함) - 갑자기 약 끊으면 더 심한 불면증 올 수 있으므로 의사의 지시에 따라 서서히 양 줄이기 고령 환자의 경우 수면제로 인한 근육 이완 효과 때문에 밤에 낙상 사고 주의	폐쇄성수면무호흡증: 양압환기, 체중감량, 호흡억제요인제거 1 수술 렘수면행동장애: 약물치료(Clonazepam, melatonin 등), 안전한 침실환경(위험한 요인 제거) 약물 장애: 체계적 탈감작, 노출치료, 인지치료 기면증: 주간졸림증-CNS 각성제(modafinil 등) 탈력발작-SSRI 등, 교육, 생활방식 변경 일주기리듬수면각성장애: 광치료(푸른 빛에 노출시켜 생체리듬 reset), 환경치료(잠들기 전 빛 노출 최소화, 아침에 퇴근할 때 선글라스 쓰기, 아침에 잘 때 침실 어둡게 하기) 하지불안증후군: 철분보충, 도파민약물 적응장애, 주요우울장애: 집단치료, 지지적/단기 정신치료, 항우울제 폐경: 호르몬 대체 요법

수면위생	
Bad 덥게/지나치게 습하게/밝게/시끄럽게 낮잠 20-30 분 이상 침대에서 식사/책/운동/전화/핸드폰/시계/TV 침대에서 걱정하기(특히나 수면에 대해) 수면 전 과식, 다량 수분 금지 수면 전 알코올/커피/녹차 금지 수면 직전 운동 금지	Good 수면환경 시원하게/어둡게/조용하게 규칙적 기상 시간 잠 잘 때만 침대에 누워있기 잠이 오지 않으면 침실 밖에서 다른 일 하기 걱정에 대해서 적어두고 잡생각 그만, 아침에 하기 배고프면 수면 전 간략한 간식 적절하고 규칙적인 운동 수면 1 시간 전 마음 가라앉히기/명상/스트레칭 수면 1 시간 전 미지근한 물 샤워
+++ Q. 인터넷에서 파는 멜라토닌 젤리/약/음료수 먹어도 될까요? 멜라토닌은 우리 몸에서 나오는 수면 호르몬이라 도움이 될 수 있지만, 현재 환자분의 불면증 원인이 무엇인지 정확히 파악하는 것이 우선입니다. 시중에 파는 제품은 함량이 일정하지 않을 수 있으니, 우선 오늘 안내해 드린 수면위생을 1~2 주간 실천해 보시고 증상이 나아지지 않으면 그때 의학적인 처방을 통해 안전하게 복용하시는 것을 추천해 드립니다. >> 주로 인터넷에서 파는 멜라토닌 용량은 (직구하지 않는 이상) 매우 적은 용량! 하지만 와르르 먹어버리면 멜라토닌 성분이 주중에 남아있게 되면서 편두통 등 다른 증상 발생 가능함. 의존도 높아질 수 있음. 근데 사실 전 먹어요.	